JISTOTA U KAŽDÉHO PACIENTA™

Příprava ke zkouškám: 150 otázek a odpovědí

Pro praktické zkoušky, státnice a klinickou praxi. Zakryjte odpověď a vyzkoušejte se.

Atlas spoušťových bodů · Vzdělávací materiál pro zdravotnické odborníky a studenty. Nenahrazuje lékařskou diagnózu.

Obsah

1 · Základní pojmy a bezpečnost

2 · Hlava, obličej a krk

3 · Rameno, paže a ruka

4 · Záda a trup

5 · Pánev a kyčel

6 · Stehno, bérec a chodidlo

Další krok

ČÁST 1

Základní pojmy a bezpečnost

30 obecných otázek.

1. Co je spoušťový bod?
Citlivý, hmatný bod v napjatém svalovém pruhu, který při tlaku může vyvolat místní a přenesenou bolest.

2. Jaký je rozdíl mezi aktivním a latentním spoušťovým bodem?
Aktivní bod způsobuje bolest i spontánně, latentní je citlivý jen na tlak.

3. Co je přenesená (referovaná) bolest?
Bolest, kterou pacient cítí v oblasti vzdálené od spoušťového bodu.

4. Co je ischemická komprese?
Trvalý, postupně zvyšovaný tlak na spoušťový bod, dokud napětí nepovolí.

5. Jak silný má být tlak?
Obvykle nepříjemnost asi 5–7 na škále 0–10, podle signálu pacienta.

6. Jak dlouho držet kompresi?
Obvykle 30–90 sekund, 3–5 opakování.

7. Proč po kompresi protahujeme?
Abychom obnovili délku napjatého pruhu a udrželi účinek.

8. Co je napjatý pruh?
Hmatná, provazcovitá, tužší skupina vláken uvnitř svalu.

9. Co je místní záškubová odpověď?
Krátké stažení napjatého pruhu při příčném „brnknutí“ přes spoušťový bod.

10. Co znamená VAS?
Vizuální analogová škála pro hodnocení intenzity bolesti od 0 do 10.

11. Které faktory udržují spoušťové body?
Špatné držení těla, opakovaná zátěž, stres, nedostatek spánku, zkrácené svaly, nečinnost.

12. Kdy pacienta neošetřovat?
Při horečce, čerstvém poranění, podezření na trombózu, noční bolesti neznámého původu, neurologických příznacích.

13. Co dělat, když se během ošetření objeví závrať?
Okamžitě přestat, a pokud neodezní, poslat pacienta k lékaři.

14. Proč je důležitý domácí program?
Protože udržující faktory působí doma a v práci; bez něj se obtíže vracejí.

15. Co je klešťový úchop a kdy ho použijete?
Uchopení bříška svalu mezi dva prsty; u povrchových, uchopitelných svalů (např. trapezius, SCM).

16. Na co si dát pozor u pacienta užívajícího antikoagulancia?
Používejte jen mírný tlak a sledujte vznik podlitin.

17. Jaký je rozdíl mezi spoušťovým bodem a tender pointem?
Spoušťový bod v napjatém pruhu může vyvolat přenesenou bolest, tender point je místní citlivost.

18. Jak zdokumentujete ošetření?
Obtíže, VAS, ošetřené svaly, technika, reakce, domácí úkol, další krok.

19. Proč vyšetřovat i svaly vzdálené od místa bolesti?
Protože kvůli přenosu bolesti je zdroj často jinde, než kde to bolí.

20. Co dělat, když tlak vyvolá necitlivost v paži?
Snížit tlak nebo přestat; při trvalé necitlivosti lékař.

21. Který sval může způsobit „bolest zubů“ bez zubní příčiny?
Nejčastěji masseter a temporalis.

22. Který sval může způsobit bolest čela a okolí očí?
SCM a subokcipitální svaly.

23. Který sval bolí vpředu, i když je vzadu?
Infraspinatus: je na lopatce a přenáší bolest do přední části ramene.

24. Který sval může napodobovat ischias?
Gluteus minimus a piriformis.

25. Který sval může způsobit bolest paty?
Soleus a quadratus plantae.

26. Na co si dát pozor při ošetření SCM?
Pouze klešťový úchop, nikdy netlačit dozadu na přední straně krku (arteria carotis).

27. Na co si dát pozor při ošetření lýtka?
Při jednostranném otoku, teplotě nebo zarudnutí nemasírovat (podezření na trombózu).

28. Na co si dát pozor při ošetření iliopsoatu?
Nikdy netlačit v blízkosti tepny; při břišních potížích a v těhotenství neošetřovat břišní část.

29. Jaká je vhodná poloha pro ošetření quadratus lumborum?
Vleže na boku, horní noha spuštěná dozadu, aby se zvětšila vzdálenost mezi pánví a žebry.

30. Proč pomáhá břišní dýchání u obtíží ze skalenových svalů?
Protože místo horního hrudního dýchání snižuje přetížení skalenů.

ČÁST 2

Hlava, obličej a krk

24 otázek.

31. Trapezius – horní vlákna: kde hledáte spoušťový bod?

Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.

32. Trapezius – horní vlákna: kam se může šířit bolest?

Spánek, strana hlavy, strana krku, za uchem, úhel dolní čelisti.

33. Sternocleidomastoideus (SCM): kde hledáte spoušťový bod?

Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

34. Sternocleidomastoideus (SCM): kam se může šířit bolest?

Čelo, okolí oka, tvář, hluboko v uchu, temeno, týl.

35. Masseter (žvýkací sval): kde hledáte spoušťový bod?

V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.

36. Masseter (žvýkací sval): kam se může šířit bolest?

Horní a dolní stoličky, dolní čelist, obočí, hluboko v uchu.

37. Temporalis (spánkový sval): kde hledáte spoušťový bod?

Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.

38. Temporalis (spánkový sval): kam se může šířit bolest?

Spánek, obočí, za okem, horní zuby, strana hlavy.

39. Pterygoideus lateralis: kde hledáte spoušťový bod?

Hluboko pod jařmovým obloukem; intraorálně za horními stoličkami, směrem nahoru a dozadu.

40. Pterygoideus lateralis: kam se může šířit bolest?

Čelistní kloub, tvář (nad čelistní dutinou).

41. Pterygoideus medialis: kde hledáte spoušťový bod?

Na vnitřní straně úhlu dolní čelisti, palpace zespodu; intraorálně za poslední stoličkou.

42. Pterygoideus medialis: kam se může šířit bolest?

Kořen jazyka, hrdlo, pod uchem, čelistní kloub.

43. Splenius capitis: kde hledáte spoušťový bod?

V zadní boční části krku, mezi SCM a trapeziem, asi 2–3 prsty pod týlem.

44. Splenius capitis: kam se může šířit bolest?

Temeno.

45. Splenius cervicis: kde hledáte spoušťový bod?

V dolní části krku, nad horním úhlem lopatky, vedle levator scapulae.

46. Splenius cervicis: kam se může šířit bolest?

Za okem, týl, přechod krku a ramene.

47. Subokcipitální svaly: kde hledáte spoušťový bod?

Přímo pod kostí týlní, po obou stranách střední čáry, v hloubce.

48. Subokcipitální svaly: kam se může šířit bolest?

Strana hlavy, za okem, čelo, týl.

49. Semispinalis capitis: kde hledáte spoušťový bod?

Na zátylku, 2–3 cm od střední čáry, pod týlem a uprostřed krku.

50. Semispinalis capitis: kam se může šířit bolest?

Strana hlavy, spánek, čelo, týl.

51. Levator scapulae (zdvihač lopatky): kde hledáte spoušťový bod?

Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.

52. Levator scapulae (zdvihač lopatky): kam se může šířit bolest?

Přechod krku a ramene, vnitřní okraj lopatky, zadní část ramene.

53. Skalenové svaly: kde hledáte spoušťový bod?

Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

54. Skalenové svaly: kam se může šířit bolest?

Přední strana hrudníku, paže, vnitřní okraj lopatky, ruka (palec a ukazovák).

ČÁST 3

Rameno, paže a ruka

28 otázek.

55. Infraspinatus: kde hledáte spoušťový bod?

Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.

56. Infraspinatus: kam se může šířit bolest?

Přední část ramene (hluboko), přední zevní strana paže, předloktí, palcová strana ruky.

57. Supraspinatus: kde hledáte spoušťový bod?

Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.

58. Supraspinatus: kam se může šířit bolest?

Strana ramene (oblast deltoideu), zevní strana paže, zevní strana lokte.

59. Teres minor: kde hledáte spoušťový bod?

Na zevním okraji lopatky, pod infraspinatem, nad zadní podpažní řasou.

60. Teres minor: kam se může šířit bolest?

Zadní část ramene (bodově), zadní strana paže.

61. Subscapularis: kde hledáte spoušťový bod?

Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.

62. Subscapularis: kam se může šířit bolest?

Zadní část ramene, lopatka, zadní strana paže, zápěstí.

63. Deltoideus: kde hledáte spoušťový bod?

V předních, středních a zadních vláknech, 2–5 cm pod akromionem.

64. Deltoideus: kam se může šířit bolest?

Rameno (kolem bodu), paže.

65. Pectoralis major: kde hledáte spoušťový bod?

Na zevním okraji prsního svalu (přední podpažní řasa), pod klíční kostí a vedle hrudní kosti.

66. Pectoralis major: kam se může šířit bolest?

Přední část hrudníku, přední část ramene, vnitřní strana paže, prsa.

67. Pectoralis minor: kde hledáte spoušťový bod?

Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.

68. Pectoralis minor: kam se může šířit bolest?

Přední část ramene, hrudník, vnitřní strana paže, malíková strana ruky.

69. Rhomboideus: kde hledáte spoušťový bod?

Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, pod trapeziem.

70. Rhomboideus: kam se může šířit bolest?

Vnitřní okraj lopatky, mezi lopatkami.

71. Serratus anterior: kde hledáte spoušťový bod?

Na straně hrudníku, pod podpažím ve výši 5.–6. žebra.

72. Serratus anterior: kam se může šířit bolest?

Boční strana hrudníku, dolní úhel lopatky, vnitřní strana paže.

73. Latissimus dorsi: kde hledáte spoušťový bod?

V zadní podpažní řase, ve výši dolního úhlu lopatky.

74. Latissimus dorsi: kam se může šířit bolest?

Dolní úhel lopatky, zadní vnitřní strana paže, prsteník a malíček.

75. Biceps brachii: kde hledáte spoušťový bod?

Ve střední třetině přední strany paže, v obou hlavách.

76. Biceps brachii: kam se může šířit bolest?

Přední část ramene, loketní jamka.

77. Triceps brachii: kde hledáte spoušťový bod?

Na zadní straně paže, v dlouhé hlavě pod podpažím a 4–6 cm nad loktem.

78. Triceps brachii: kam se může šířit bolest?

Zadní část ramene, zevní strana lokte, zadní strana předloktí.

79. Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum): kde hledáte spoušťový bod?

Na zadní zevní straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.

80. Extenzory předloktí (ECRL, ECRB, extensor digitorum): kam se může šířit bolest?

Zevní strana lokte, zadní strana předloktí, hřbet ruky, prsty.

81. Flexory předloktí: kde hledáte spoušťový bod?

Na vnitřní přední straně předloktí, 3–6 cm pod loktem.

82. Flexory předloktí: kam se může šířit bolest?

Dlaňová strana zápěstí, dlaň, dlaňová strana prstů.

ČÁST 4

Záda a trup

20 otázek.

83. Trapezius – střední vlákna: kde hledáte spoušťový bod?

Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, ve výši hřebene lopatky, povrchově.

84. Trapezius – střední vlákna: kam se může šířit bolest?

Mezi lopatkami, pálení vedle páteře.

85. Trapezius – dolní vlákna: kde hledáte spoušťový bod?

Mezi dolním úhlem lopatky a páteří, ve střední části zad.

86. Trapezius – dolní vlákna: kam se může šířit bolest?

Zadní strana krku, akromion, mezi lopatkami.

87. Serratus posterior superior: kde hledáte spoušťový bod?

Pod horní částí lopatky, vedle páteře; dosažitelný po odtažení lopatky do strany.

88. Serratus posterior superior: kam se může šířit bolest?

Hluboko pod lopatkou, zadní část ramene, zadní strana paže, malíček.

89. Iliocostalis thoracis: kde hledáte spoušťový bod?

Asi 5–8 cm od páteře, ve střední a dolní hrudní oblasti.

90. Iliocostalis thoracis: kam se může šířit bolest?

Střed zad, břicho (někdy), pod lopatkou.

91. Iliocostalis lumborum: kde hledáte spoušťový bod?

V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.

92. Iliocostalis lumborum: kam se může šířit bolest?

Kříž, hýždě, dolní část břicha.

93. Longissimus thoracis: kde hledáte spoušťový bod?

2–4 cm od páteře, v dolní hrudní a horní bederní oblasti.

94. Longissimus thoracis: kam se může šířit bolest?

Hýždě, kříž, hřeben kosti kyčelní.

95. Multifidus: kde hledáte spoušťový bod?

Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce, v kterékoli oblasti páteře (nejčastěji bederní).

96. Multifidus: kam se může šířit bolest?

Bodově vedle páteře, kost křížová, břicho (vzácně).

97. Quadratus lumborum: kde hledáte spoušťový bod?

Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.

98. Quadratus lumborum: kam se může šířit bolest?

Hřeben kosti kyčelní, hýždě, strana kyčle, kříž.

99. Rectus abdominis: kde hledáte spoušťový bod?

Nad pupkem a pod ním, 2–4 cm od střední čáry.

100. Rectus abdominis: kam se může šířit bolest?

Vodorovný pruh přes střed zad, břicho, kříž.

101. Obliquus externus abdominis: kde hledáte spoušťový bod?

Na straně břicha, pod žeberním obloukem a nad hřebenem kosti kyčelní.

102. Obliquus externus abdominis: kam se může šířit bolest?

Strana břicha, kříž, dolní část hrudníku.

ČÁST 5

Pánev a kyčel

20 otázek.

103. Gluteus maximus: kde hledáte spoušťový bod?
V dolní vnitřní části hýždě, vedle kosti křížové a nad sedacím hrbolem.

104. Gluteus maximus: kam se může šířit bolest?
Hýždě, kost křížová, okolí kostrče.

105. Gluteus medius: kde hledáte spoušťový bod?
2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.

106. Gluteus medius: kam se může šířit bolest?
Dolní část kříže, kost křížová, strana kyčle, hýždě.

107. Gluteus minimus: kde hledáte spoušťový bod?
Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.

108. Gluteus minimus: kam se může šířit bolest?
Zevní strana stehna, zevní strana bérce, zadní strana stehna, kotník.

109. Piriformis: kde hledáte spoušťový bod?
Ve střední a zevní třetině spojnice mezi zevním okrajem kosti křížové a vrcholem velkého trochanteru.

110. Piriformis: kam se může šířit bolest?
Hýždě, kost křížová, zadní strana stehna, zadní část kyčelního kloubu.

111. Iliopsoas: kde hledáte spoušťový bod?
Na přední straně stehna pod tříselným vazem (laterálně od a. femoralis) a v břiše na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní.

112. Iliopsoas: kam se může šířit bolest?
Kříž vedle páteře, kost křížová, přední strana stehna.

113. Tensor fasciae latae (TFL): kde hledáte spoušťový bod?
V přední zevní části kyčle, pod spina iliaca anterior superior.

114. Tensor fasciae latae (TFL): kam se může šířit bolest?
Zevní strana stehna, zevní strana kolena.

115. Adductor longus: kde hledáte spoušťový bod?
Na vnitřní straně stehna, v horní třetině.

116. Adductor longus: kam se může šířit bolest?

Tříslo, vnitřní strana stehna, vnitřní strana kolena.

117. Adductor magnus: kde hledáte spoušťový bod?

Na vnitřně-zadní straně stehna, ve střední třetině, a v blízkosti sedacího hrbolu.

118. Adductor magnus: kam se může šířit bolest?

Tříslo, vnitřní strana stehna, hluboko v pánvi.

119. Pectineus: kde hledáte spoušťový bod?

Na vnitřně-přední straně stehna, pod tříselným ohbím, mediálně od a. femoralis.

120. Pectineus: kam se může šířit bolest?

Hluboko v třísle, vnitřně-přední strana stehna.

121. Sartorius: kde hledáte spoušťový bod?

Šikmo přes přední stranu stehna, od předního hrotu kosti kyčelní k vnitřní straně kolena, povrchově.

122. Sartorius: kam se může šířit bolest?

Přední strana stehna (pálivý, bodavý pocit), vnitřní strana kolena.

ČÁST 6

Stehno, bérec a chodidlo

28 otázek.

123. Rectus femoris: kde hledáte spoušťový bod?
Na přední straně stehna, těsně pod kyčlí, v blízkosti spina iliaca anterior inferior.

124. Rectus femoris: kam se může šířit bolest?
Přední část kolena, kolem čéšky.

125. Vastus medialis: kde hledáte spoušťový bod?
Na vnitřní přední straně stehna, 5–10 cm nad kolenem.

126. Vastus medialis: kam se může šířit bolest?
Vnitřní strana kolena, přední část kolena.

127. Vastus lateralis: kde hledáte spoušťový bod?
Na zevní straně stehna, v několika bodech mezi kyčlí a kolenem.

128. Vastus lateralis: kam se může šířit bolest?
Zevní strana stehna, zevní strana kolena, za čéškou.

129. Biceps femoris: kde hledáte spoušťový bod?
Na zadní zevní straně stehna, ve střední a dolní třetině.

130. Biceps femoris: kam se může šířit bolest?
Podkolenní jamka, zadní strana stehna.

131. Semitendinosus / semimembranosus: kde hledáte spoušťový bod?
Na zadní vnitřní straně stehna, ve střední a dolní třetině.

132. Semitendinosus / semimembranosus: kam se může šířit bolest?
Dolní část hýždě, zadní strana stehna, vnitřní strana podkolenní jamky.

133. Gastrocnemius: kde hledáte spoušťový bod?
V horní části lýtka, ve vnitřní a zevní hlavě, pod podkolenní jamkou.

134. Gastrocnemius: kam se může šířit bolest?
Klenba nohy, lýtko, podkolenní jamka.

135. Soleus: kde hledáte spoušťový bod?
V dolní části lýtka, hluboko pod gastrocnemiem, nad Achillovou šlachou.

136. Soleus: kam se může šířit bolest?
Pata, lýtko, kost křížová (vzácně).

137. Tibialis anterior: kde hledáte spoušťový bod?
Laterálně vedle holenní kosti, v horní třetině bérce.

138. Tibialis anterior: kam se může šířit bolest?
Přední strana kotníku, palec nohy.

139. Peroneus (fibularis) longus: kde hledáte spoušťový bod?
Na zevní straně bérce, v horní třetině, 2–4 cm pod hlavičkou fibuly.

140. Peroneus (fibularis) longus: kam se může šířit bolest?
Zevní kotník, zevní strana nohy.

141. Tibialis posterior: kde hledáte spoušťový bod?
Hluboko pod lýtkem, za vnitřně-zadním okrajem holenní kosti.

142. Tibialis posterior: kam se může šířit bolest?
Achillova šlacha, pata, chodidlo.

143. Extensor digitorum longus: kde hledáte spoušťový bod?
Na přední zevní straně bérce, laterálně vedle tibialis anterior, v horní třetině.

144. Extensor digitorum longus: kam se může šířit bolest?
Hřbet nohy, prostřední prsty nohy.

145. Flexor digitorum brevis: kde hledáte spoušťový bod?
Uprostřed chodidla, před patou.

146. Flexor digitorum brevis: kam se může šířit bolest?
Střed chodidla, kořeny prstů nohy.

147. Abductor hallucis: kde hledáte spoušťový bod?
Na vnitřním okraji chodidla, mezi patou a kořenem palce.

148. Abductor hallucis: kam se může šířit bolest?
Vnitřní strana paty, vnitřní okraj klenby.

149. Quadratus plantae: kde hledáte spoušťový bod?
V zadní části chodidla, v hloubce, těsně před patní kostí.

150. Quadratus plantae: kam se může šířit bolest?
Plantární plocha paty.

Další krok

Dnes: odpovězte na prvních 30 otázek bez odpovědí a označte si ty, které jste nevěděli.